

Hystérectomie par voie vaginale (pour Prolapsus)

WARWIKI

Information pour le patient · Ablation de l'utérus par le vagin, avec suspension du fond vaginal

Lorsque l'utérus est descendu dans le cadre d'un prolapsus des organes pelviens, une option est l'**hystérectomie par voie vaginale** — retirer l'utérus entièrement par le vagin, **sans incision abdominale**. Elle est presque toujours associée à une **suspension** du fond du vagin (et souvent d'autres réparations) pour un bon soutien après l'opération.

À propos de cette intervention

L'utérus est décollé et retiré par le vagin. Ensuite, le **fond du vagin est suspendu** à vos propres ligaments pelviens solides pour prévenir un nouveau prolapsus. Des réparations de la paroi antérieure ou postérieure peuvent être ajoutées selon votre examen. La voie vaginale implique généralement **moins de douleur et une récupération plus rapide** que la voie abdominale.

Ce qu'il faut savoir

- L'ablation de l'utérus met fin aux règles et à la possibilité de porter une grossesse.
- Si le prolapsus concerne principalement l'utérus et que vous souhaitez **le conserver**, une suspension sans ablation (hystéropexie) peut être une option — demandez à votre chirurgien.
- Un geste séparé pour une **fuite urinaire** peut être ajouté si nécessaire.

COMPRENDRE LES TERMES

Hystérectomie

Chirurgie pour retirer l'utérus.

Voie vaginale

Réalisée par le vagin, sans incision abdominale.

Suspension du fond vaginal

Fixation du sommet du vagin pour qu'il reste bien soutenu.

Hystéropexie

Alternative conservant l'utérus, qui le suspend sans l'enlever.

Prolapsus

Descente d'organes pelviens provoquant une sensation de boule ou de pression.

Méchage vaginal

Gaze placée brièvement après l'opération pour favoriser la cicatrisation.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention se déroule sous anesthésie, vous ne ressentez rien pendant. Sans incision abdominale, la récupération est généralement plus facile que par d'autres voies — attendez-vous à des douleurs légères à modérées ; la plupart des patientes rentrent le jour même ou après une nuit.

Comment vous préparer

- Suivez les **consignes d'anesthésie** (jeûne, arrêt des anticoagulants selon les instructions).
- Un bilan préopératoire ; discutez des réparations supplémentaires ou d'un geste anti-fuites éventuels.
- Ne fumez pas ; prévoyez un accompagnant et de l'aide à domicile.

Déroulement

- 1 Vous êtes sous anesthésie ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 L'utérus est décollé et retiré **par le vagin**.
- 3 Le fond du vagin est **suspendu** à vos ligaments ; les réparations prévues sont réalisées.
- 4 Une sonde et parfois un méchage vaginal sont placés brièvement.

Après l'opération

- Des pertes légères pendant quelques semaines sont normales pendant la cicatrisation du fond vaginal.
- **Évitez les efforts, la constipation et les rapports sexuels pendant environ 6 semaines.**
- Gardez des selles molles pour éviter de pousser ; reposez-vous, puis reprenez l'activité progressivement.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons, ou un saignement abondant
- **L'impossibilité d'uriner**, ou une douleur pelvienne/abdominale qui s'aggrave
- Des pertes malodorantes, ou quelque chose qui sort par le vagin

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'hystérectomie par voie vaginale retire l'utérus par le vagin (sans incision abdominale) et inclut une suspension du fond vaginal.
2. Elle met fin aux règles et à la grossesse ; si vous souhaitez conserver votre utérus, demandez une suspension conservatrice.
3. Évitez les efforts et les rapports ~6 semaines ; des pertes légères sont normales. Appelez en cas de fièvre, saignement abondant ou difficulté à uriner.